



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : منى السيد احمد مخيمر

العنوان : اسنيت مركز كفر شكر-
القليوبيه

الحي / المدينة : كفر شكر

المحافظة : القليوبيه

تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

رقم البطاقة : 28109290102062 رقم التليفون : 01016543142

العمر(تاريخ الميلاد) : 29-09-1981 المهنة : حاصل علي دبلوم

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض
بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. ----- /د. ----- /د. ----- /د. -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----
قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منى السيد احمد مخيم National ID: 28109290102062	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Bone scintigraphy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



١٧٧٥
مقبولة
مسعري

 جمهورية مصر العربية لخدمة صحة المرأة المصرية		05/01/2025	
MDT FORM			
Name:	Fatima Abdelsalam Gouda Hassanen	MRN:	3166
Age:	57 Y	ID:	26902172200763
Menopausal Status:	post	Phone:	01005766814
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:	-VE	Reason Of MDT:	post op

Clinical Data:

BX: RIGHT IDC G2
ER 8 **PR** 7 **HER** 3 **KI67** 50

Sonomammography:

Mets Workup:

History:

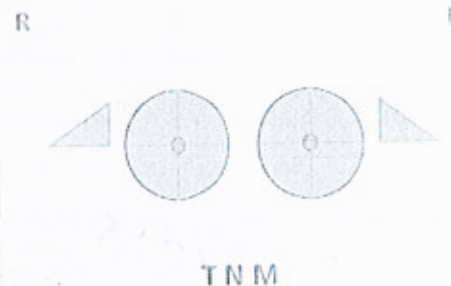
Initially cT2 n1 Right breast cancer (Post-NACT), Right breast wide local excision, Sentinel lymph nodes biopsy & Extra-lymph nodes: - No residual viable remnants of the previously diagnosed invasive tumor. ? Ductal carcinoma in situ: Absent. ? Surgical margins: Free. + Total nodal status: Eight free lymph nodes (0/8). - Histologic response to therapy:

Recommendations:

for adj ttt

MDT Outcome & Plan

PORT
 CONTINUE ADJUVANT PHESGO
 ADJUVANT AI



SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
					

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

جهة الإصدار: فرع القابلية

تاريخ الإصدار: 2024-1-15

إلى من يهمه الأمر

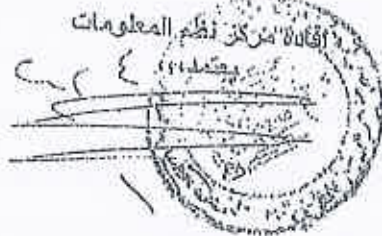
الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة الانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المنطل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والإراقة" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس وقانون رقم 86 لسنة 2012 "الإطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المسيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والمبحث تبين أن

السيد (ة) منى السيد احمد مخيمر بطاقة رقم 28109290102062
وطبقا إلى خطاب من التأمينات الاجتماعية وفرد عدم الانتفاع
باعتبار من الفئات غير المستفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون أي مسؤولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2024-1-15

الموظف المختص

عالمه السيد



مستلم 1223939

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار



Pathology Report

Name: منى السيد احمد

Age: 38 years.

Clinical data: Right breast cancer.

Specimen type: Right MRM

Date: 20/8/2019

Lab. Number: 714

Hospital Number: 2913/2019

Gross Description:

MRM breast tissue; 22x17x7 cm, skin ellipse; 22x15 cm including nipple and areola. It showed an ill-defined firm greyish white mass; 7x6 cm and another capsulated lobulated greyish white mass; 6.6x6 cm, located 1cm apart. Rest of breast showed wide nodular greyish pink tissue. The least margin (deep) was 1.5 cm. axillary tissue measured; 12x9 cm entangling 20 nodules, largest is 2.5x2.5 cm.

Microscopic Examination:

histopathological examination of sections prepared from the tumour mass reveals poorly fixed infiltrating malignant epithelial growth made up of small groups and thin cords of pleomorphic hyperchromatic malignant lobular epithelial cells. Admixed with groups and sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are moderate [grade II]. Surrounding breast tissue showed autolyzed fibroadenoma and multiple foci of DCIS. Positive lymphovascular emboli. Positive perineural invasion. Nipple showed scattered ghosts of tumor cells with free epidermis. The surgical margins are free. 9 out of the 22 lymph nodes detected show metastatic deposits.

Diagnosis:

Right breast cancer, MRM;

Poorly fixed. Mixed ductal and lobular carcinoma GII.

Surrounding breast showed multiple foci of DCIS and autolyzed fibroadenoma.

Nipple: scattered ghosts of tumour cell with free epidermis

Positive lymphovascular emboli.

Positive perineural invasion.

Free margin.

Lymph node 9/22.

Stage: T3N2.

Prof. Dr. Lubna Omar

Prof. Dr. Essam Ayad
Dr. Marwa Mahmoud

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



ent ID:

ID# : منى السيد احمد مخفر

Sex:

MDT Form
3- Medical number:
Female

#3152355

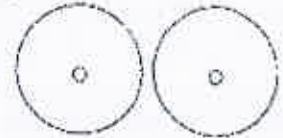
Old Med :

Old Med :

2913/2019

number: 29109290102062

Patient Age : 42 Y



History	Family History +VIE	Phone	Phone 01026543142	DM	DM	REASON OF MDY	REASON OF HNT AENH
el status	Marital Status MARRIED	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP	Date of MDY	Date of HNT
ability	Co Morbidity DM	Menopausal status	Menopausal Status POSTMENOPAUSAL	Initial STAGE	Initial STAGE	28/02/2024	U

Clinical data

st Imaging :

Mets Workup :

ER 0/8 ER COMMENTS:	PR 0/8 PR COMMENTS:	Mer 2 Met 0 Mer 2 Met COMMENTS:	SISH SISH COMMENTS:	KI67
---------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------------	------

M	M BONE?
---	------------

mammography

M BIRADS I

HENT HISTORY

MRM PT3 N2 M0-->ADJ ACX4-->TAXOL 12WK LAST ONE ON 2020
CAP 6/23-->WELL DEFINED SCLEROTIC LYTIC OSSEOUS LESIONS
NE SCAN-->6/2023-->2 RT SACRO ILIAC REGION AND TROCHANTERIC REGION OF LT FEMUR
STLY METS
0-1, NO PAIN, NO TENDERNESS
E NO MASSES,, SHE IS ON FOLLOW UP SINCE 2020
FURTHER TTT

MDT OUTCOME & PLAN

CORE & PLAN

pan CTs , US & BONE SCAN...

TAXOL WEEKLY & ZOMETA EVERY 3 MS.

ICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY	SIGNATURE	RADIOLOGY
GERY	SURGERY		PATHOLOGY
iatric	Psychiatric		Nutrition



Total DLP (mGy.cm) | :

Patient Name: Mona Al Sayed Ahmed Mekhemer	Date : 14/05/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 2913/2019	Pat. ID: 42840

- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Skeletal survey shows:
 - Bilateral inferior and left superior pubic rami and left symphysis pubis multiple fractures with callus formation.
 - Left 5th-10th ribs fracture with callus formations some show malalignment.
 - L1 vertebral body, left proximal femoral shaft and left ischial bone sclerotic bone lesions and right iliac mixed mainly sclerotic bone lesion.

Opinion:

- No CT evidence of pulmonary or hepatic metastatic deposits, on non contrast study.
- Bilateral inferior and left superior pubic rami and left symphysis pubis multiple fractures, left 5th-10th ribs fractures.
- L1 vertebral body, left proximal femoral shaft and left ischial bone sclerotic bone lesions and right iliac mixed mainly sclerotic bone lesion, could be metastatic for bone scan correlation.

Dr. Nancy Gamal
Dr. Reham Anwar, FEBR, MD

Patient No. : 2913-2019
Patient Name : الأستاذ / منى السيد احمد مخيمر
Sex : Female Age: 43 Y
Financial Cate : نفقة الدولة - جوستاف روسي
Department : Out Patient
Referring Doc :

Request No : 13004626
Request Date : 07-10-2025 13:31
Verification Date : 07-10-2025 13:56
Sample Type : Serum
Test Status : Routine
Analyzers : Gem3000_1_Hermel

Clinical Chemistry Report

Test	Result	Unit	Ref. Range
Calcium Ionized (Ca++)	<u>0.97</u>	mmol/l	1.10 - 1.30)

Signature

Dr./Radwa Younes

Printing By : Eman Hamdi

987 كورنيش النيل الملك الصالح

Printing Date : 07/10/2025 15:15:04

Page 1 of 1

25311121 / فاكس

25311128 - 25311125 / ت



Total DLP (mGy.cm)]:

Patient Name: Mona Al Sayed Ahmed Mekhemer	Date : 14/05/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 2913/2019	Pat. ID: 42840

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Right MRM is noted
- Right upper lobar subpleural reticulations likely postradiotherapy changes.
- Clear the rest both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes (apart from bilateral renal cortical cysts)
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.

د. أحمد كمال الدري
د. محمد أبو الهدى درويش
د. عمر حسين عمر
د. وحيد حسين طنطاوي
أساتذة الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

Mrs. Mona Al Sayed Ahmed Mekhemer Patient ID: 916153
Ref. Phy.: Ibrahim Mohamed Abo arais Study Date: 29/09/2025

TC-99m MDP WHOLE BODY BONE SCAN

History

- 44-year-old female patient who gave history of surgically treated right breast cancer few years ago, complains of bony aches and referred for metastatic work up.

Technique

- Anterior and posterior whole-body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

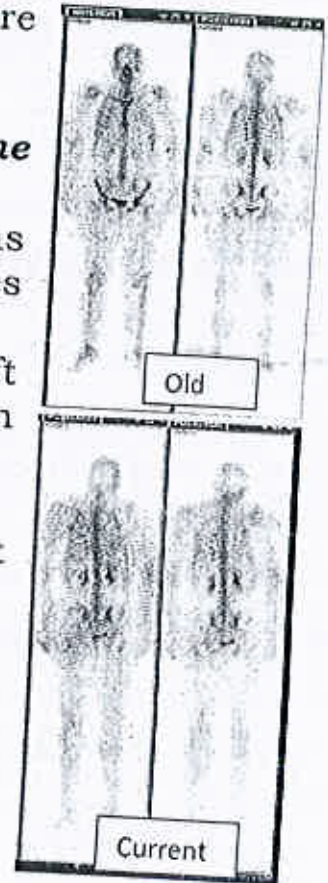
Findings

Compared to last scan dated 23-6-2025, the current scan revealed.

- Rather stationary course of old osseous lesions at the left acetabulum, bilateral ischial bones and trochanteric region of the left femur.
- Multiple active osseous lesions involving the left side of the ribs posteriorly in linear pattern likely post traumatic sequel.
- No newly developed osseous lesions detected.
- Degenerative changes are noticed at different levels of the spine.

IMPRESSION

- Rather stationary course of the previous osseous lesions at the aforementioned sites likely metastatic, for regional radiological correlation and follow up.



Much Obligated
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

[Handwritten signature]

MRS. MONA AL SAYED A. MEKHEMER
DEAR SIR

PATIENT ID: 916153

STUDY DATE: 25/02/2026

-

- No suspicious pelviabdominal lesions.
- Stationary fatty liver with no focal lesion and bilateral renal cortical cysts.
- Stable sclerotic osseous lesions and partially healing fractures.

MUCH OBLIGED

MUCH OBLIGED

PROF DR. AHMED FATHY

PROF.DR. YASSER IBRAHIM

Branch (1) : 8 El Khalifa El Maamoun St. Heliopolis ☎+20219333333

11 El Merghany St., Heliopolis
 Off 90th Street

iro Branch : Off 90th Street, behind the Air Force Hospital
Branch No. 1

Branch Number: 17027 01020719773

19773
+20219773

فرع مصر الجديدة (1) شارع الخليفة المأمون مصر الجديدة
 فرع مصر الجديدة (2) الشارع الميموني، مصر الجديدة
 فرع التجمع الخامس، شارع التسعين خلف المستشفى الجوى
 رقم الفرع: ٢٧، ١٧ ©

شارع التجميع الخامس، شارع القسحين خلف الصناديق
رقم القاع: ١٧، ٢٧

أ.د. أحمد كمال الدري
أ.د. محمد أبو الهدي درويش
أ.د. عمر حسين عمر
أ.د. وحيد حسين طنطاوي
أ.د. ياسر عبد العظيم عباس
أ.د. أحمد محمد منيب
أساتذة الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

MRS. MONA AL SAYED A. MEKHEMER
DEAR SIR

PATIENT ID: 916153
STUDY DATE: 25/02/2026

This female patient with history of right mastectomy for breast cancer, in comparison to the previous study dated 29/9/2025, the current study revealed:

MULTISLICE C.T. SCAN OF THE CHEST

Multislice axial contiguous thin cuts were taken through the chest after I.V. non-ionic contrast injection.

FINDINGS:-

- Clear right mastectomy operative bed.
 - No suspicious enhancing left breast lesions.
 - Stable few small benign looking left axillary lymph nodes having preserved ovoid outline and fatty hilum, the largest is measuring 16mm, mostly reactionary.
 - Both lungs show normal appearance of their parenchyma and pulmonary vasculature.
 - No pulmonary masses, nodules or consolidation patches.
 - Still noted subpleural faint reticular infiltrates are seen in the anterior segment of the right upper and middle lobes, mostly of post radiation sequel.
 - Normal C.T. appearance of the mediastinal structures.
 - Left sided Port-A-Cath is seen with its distal end reaching the inferior aspect of the superior vena cava.
 - No significant mediastinal or hilar adenopathy.
 - Patent tracheo bronchial tree.
- IMPRESSION:-**
- Clear right mastectomy operative bed with no suspicious pulmonary or nodal lesions.

MULTISLICE C.T. SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS:-

Multislice post contrast CT scan of the abdomen and pelvis with multiplanar reformatted images revealed:-

FINDINGS:-

- Stationary fatty liver with no suspicious focal lesions.
- No intra or extrahepatic biliary dilatation.